보건복지부 고시 제2026-222호

「국민건강보험법」 제41조제3항 및 제4항, 「국민건강보험 요양급여 기준에 관한 규칙」제5조제2항에 따라「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」(보건복지부 고시 제2026-192호(2026. 9. 29.)을 다음과 같이 개정·발령합니다.

2026년 10월 29일

보건복지부장관

「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 일부개정

요양급여의 적용기준 및 방법에 대한 세부사항 일부를 다음과 같이 개정한다.

Ⅱ. 약제 "[117] Esketamine hydrochloride 외용제(품명: 스프라바토나잘스프레이), [232] Vonoprazan fumarate 경구제(품명 : 보신티정10밀리그램 등), [232] Vonoprazan tosylate 경구제(품명 : 보노칸정10밀리그램 등), [399] Lumasiran sodium 주사제(품명: 옥스루모주)"를 별지 1과 같이 신설하고, "[일반원칙] 고가의약품 급여관리에 관한 기준, [333] Edoxaban Tosilate Hydrate 경구제(품명: 릭시아나정 15밀리그램 등), [399] Burosumab 주사제(품명: 크리스비타주사액), [439] Aflibercept 주사제(품명: 아일리아주사, 아일리아프리필드시린지 등), [439] Ranibizumab 주사제(품명:루센티스주 등, 루센티스프리필드시린지 등), [619] Clostridium botulinum A toxin 주사제(품명: 보톡스주 등), [629] Letermovir 경구제(품명: 프레비미스정 240, 480밀리그램), Letermovir 주사제(품명: 프레비미스주 240, 480밀리그램)"의 세부인정기준 및 방법의 일부를 별지 2와 같이 변경한다.

부 칙

이 고시는 2026년 11월 1일부터 시행한다.

변경대비표

[별지 1]

[117] 정신신경용제

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[117] Esketamine hydrochloride 외용제 (품명: 스프라바토나잘스프레이)	<신 설>	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 투여대상 18세 이상 65세 미만의 성인의 주요 우울장애 환자 중 다음의 조건을 모두 만족하는 경우 - 다 음 - 1) 최소 2개 이상의 서로 다른 경구 항우울제와 1개 이상의 항정신병약제를 각각 최소 8주 이상 충분한 내약용량으로 투여하였으나 최초 항우울제 투여 시점보다 50% 이상 증상 개선을 보이지 않은 환자 2) 동 약제 투여 전 아래의 인정가능한 우울증 평가척도※ 중 1개 이상 사용하여 평가한 결과 '고도(severe)'인 경우 - 아 래 - ※ 우울증 평가척도 및 '고도(severe)'의 기준 점수 평가척도 / 기준 벡 우울 평가 BDI (Beck Depression Inventory) / 29점 이상 MADRS 우울척도 (Montgomery-Asberg Depression Rating Scale) / 35점 이상	○ Esketamine 외용제(품명: 스프라바토나잘스프레이)가 신규등재 예정임에 따라, 교과서, 가이드라인, 임상논문, 학회의견 등을 참조하여 급여기준을 신설함.

지역사회 역학조사용 우울척도 CES-D (Center for Epidemiological Studies-Depression Scale)	25점 이상
간이 우울 증상 평가 척도 QIDS (Quick Inventory of Depressive Symptomatology)	16점 이상
해밀톤 우울 검사 HAM-D (Hamilton Depression Rating Scale)	24점 이상
PHQ-9 우울척도 (Patient Health Questionnaire-9)	20점 이상

3) 다른 정신병적 양상을 동반하지 않음

나. 평가방법

1) 동 약제를 4주 투여 후 평가하여 동 약제 최초 투여시점보다 우울증 평가척도 점수가 50% 이상 감소한 경우 이후 6개월의 투여를 인정함.
2) 첫 평가 이후 6개월 투여하여 재평가 시 최초 평가 결과가 유지되면 추가 6개월의 투여를 인정하며, 그 이후 투여부터는 전액본인부담함.
(평가 및 재평가는 최초 투여시점과 동일한 우울증 평가척도를 사용함)

다. 재투여

동 약제 투여 후 우울증 평가척도 점수가 50% 이상 감소하는 반응을 보인 이력이 있으나, 새로운 우울 에피소드가 발생하여 투여대상에 해당하는 경우 이전 동 약제 중단 시점 12개월 후 투여 가능함.

2. 허가사항의 식약처 용법·용량(투여 전 고려사항, 권장용량 등) 및 주의사항(경고, 이상반응, 일반적주의 항목 등)을 반드시 참고하여 임상적 유용성이 위험성보다 높은지 신중하게 고려하여 투여하여야 함.

		3. 동 약제는 약물 사용관리 프로그램에 등록된 의료기관의 정신건강의학과 전문의가 처방하여야 하며, 최초 투여 시 투여대상 및 지속투여 시 반응평가에 대한 객관적 자료(약제투여 과거력, 평가척도 등)을 반드시 제출하여야함.	

※ 관련근거

1) Current Diagnosis & Treatment Psychiatry, 4e(2024)
2) DiPiro's Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach, 13e(2023)
3) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 14th Edition, 14e(2023)
4) Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e(2022)
5) 한국형 우울장애 약물치료 지침서(KMAP-DD) 2025
6) CANMAT 2023 Update on Clinical Guidelines for Management of Major Depressive Disorder in Adults
7) VA/DoD Clinical Practice Guideline For The Management of Major Depressive Disorder(2022)
8) The 2020 Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists clinical practice guidelines for mood disorders
9) Popova et al. Efficacy and Safety of Flexibly Dosed Esketamine Nasal Spray Combined With a Newly Initiated Oral Antidepressant in Treatment-Resistant Depression: A Randomized Double-Blind Active-Controlled Study. Am J Psychiatry. 2019 Jun 1;176(6):428-438.
10) Ochs-Ross et al. Efficacy and Safety of Esketamine Nasal Spray Plus an Oral Antidepressant in Elderly Patients With Treatment-Resistant Depression-TRANSFORM-3. Am J Geriatr Psychiatry. 2020 Feb;28(2):121-141.
11) Wajs et al. Esketamine Nasal Spray Plus Oral Antidepressant in Patients With Treatment-Resistant Depression: Assessment of Long-Term Safety in a Phase 3, Open-Label Study(SUSTAIN-2). JClin Psychiatry. 2020 Apr 28;81(3):19m12891.
12) Zaki et al. Safety and efficacy with esketamine in treatment-resistant depression: Long-Term extensino study. International Journal of Neuropsychopharmacology, 2025, Vol. 28, No. 6.
13) Fu et al. Esketamine Nasal Spray for Rapid Reduction of Major Depressive Disorder Symptoms in Patients Who Have Active Suicial Ideation With Intent: Double-Blind, Randomized Study. J Clin Psychiatry. 2020 May 12;81(3):19m13191.
14) Ionescu et al. Esketamine Nasal Spray for Rapid Reduction of Depressive Symptoms in Patients With Major Depressive Disorder Who Have Active Suicial Ideation With Intent: Results of a Phase 3, Double-Blind, Randomized Study. International Journal of Neuropsychopharmacology (2021) 24(1): 22-31.
15) 대한우울조울병학회(대우조 제2025-04호, 2025.7.1., 대우조 제2025-06호, 2025.10.1.)
16) 대한정신약물학회(대정약 제2025-21호, 2025.7.2., 대정약 제2025-32호, 2025.10.1.)
17) 대한신경정신의학회(대신정 제2025-232호, 2025.7.8., 대신정 제2025-313호, 2025.9.30.)

[232] 소화성궤양용제			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[232] Vonoprazan fumarate 경구제 (품명 : 보신티정 10밀리그램 등), Vonoprazan tosylate 경구제 (품명 : 보노칸정 10밀리그램 등)	<신 설>	각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 1. 20mg 가. 위궤양 치료 나. 미란성 위식도역류질환 치료 2. 10mg 가. 미란성 위식도역류질환 치료 후 유지요법 - 단, 식약처 허가사항에 따라 유지요법 중 효과가 충분하지 않은 경우 20mg을 투여 할 수 있음 나. 비스테로이드성소염진통제(NSAIDs) 투여 시 위궤양 또는 십이지장궤양 재발 방지	○ Vonoprazan fumarate 경구제 (품명 : 보신티정10밀리그램 등), Vonoprazan tosylate 경구제(품명 : 보노칸정10밀리그램 등)가 신규 등재 예정임에 따라, 교과서, 가이드라인, 임상논문, 학회의견 등을 참조하여 급여기준을 신설함.

※ 관련근거

1) Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease (2026)
2) Current Medical Diagnosis & Treatment 2026
3) Goldman-Cecil Medicine (2024)
4) American Society for Gastrointestinal Endoscopy guideline on the diagnosis and management of GERD: summary and recommendations (2025)
5) Evidence-based clinical practice guidelines for gastroesophageal reflux disease 2021

6) Evidence-based clinical practice guidelines for peptic ulcer disease 2020
7) Ashida K, et al. Randomised clinical trial: vonoprazan, a novel potassium-competitive acid blocker, vs. lansoprazole for the healing of erosive oesophagitis Aliment Pharmacol Ther 2016; 43: 240−251
8) Xiao Y, et al. Phase III, randomised, double-blind, multicentre study to evaluate the efficacy and safety of vonoprazan compared with lansoprazole in Asian patients with erosive oesophagitis Gut. 2020 Feb;69(2):224-230
9) Loren Laine et al. Vonoprazan Versus Lansoprazole for Healing and Maintenance of Healing of Erosive Esophagitis: A Randomized Trial. Gastroenterology. 2023;164(1):61-71
10) Ashida K, et al. Maintenance for healed erosive esophagitis: Phase Ⅲ comparison of vonoprazan with lansoprazole World J Gastroenterol 2018 April 14; 24(14): 1550-1561
11) Naomi Uemura et al. Vonoprazan as a Long-term Maintenance Treatment for Erosive Esophagitis: VISION, a 5-Year, Randomized, Open-label Study Clinical Gastroenterology and Hepatology 2025;23:748-757
12) Yinglian Xiao, et al. Vonoprazan 10mg or 20mg vs. lansoprazole 15mg as maintenance therapy in Asian patients with healed erosive esophagitis: A randomized controlled trial Chinese Medical Journal 2024;137(8);962-971
13) Miwa H, et al. Randomised clinical trial: efficacy and safety of vonoprazan vs. lansoprazole in patients with gastric or duodenal ulcers − results from two phase 3, non-inferiority randomised controlled trials Aliment Pharmacol Ther 2017; 45: 240−252
14) Mizokami Y, et al. Vonoprazan prevents ulcer recurrence during long-term NSAID therapy: randomised, lansoprazole-controlled non-inferiority and single-blind extension study Gut2018;67:1042−1051
15) 대한소화기학회(대소학 2026-011호, 2026.2.2)

[399] 따로 분류되지 않는 대사성 의약품			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[399] Lumasiran	<신 설>	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 -	○ Lumasiran sodium 주사제(품명: 옥스루모주)가 신규 등재 예정임에

sodium 주사제(품명: 옥스루모주)		가. 투여대상 1) AGXT 유전자의 이중대립유전자(biallelic) 변이(pathogenic/likely pathogenic variant)가 확인된 모든 연령의 제1형 원발성 고옥살산뇨증(PH 1, Primary hyperoxaluria type 1) 환자로서 다음의 조건을 모두 만족하는 경우 - 다 음 - 가) 옥살산 측정 수치가 아래 중 1개를 만족하는 경우 - 아 래 - (1) 24시간 요 수집이 가능한 경우 24시간 요 옥살산(UOx, Urine oxalate) 배설량이 정상 상한치(ULN) × 1.5 이상 (2) 24시간 요 수집이 불가하여 단일 검체(Spot urine) 측정을 하는 경우 연령 보정 요 옥살산/크레아티닌 비율(UOx:Cr ratio)이 정상 상한치(ULN) × 1.5 이상 (3) 요 옥살산 측정이 불가하다고 판단되는 다음의 환자 중 혈장 옥살산(POx, Plasma oxalate) ≥ 20μmol/L인 경우 (투여 소견서를 첨부하여야 하며, 투석 환자는 투석 전 채혈을 기준으로 함) - 다 음 - (가) 만성 신장 질환 4단계 이상(eGFR < 30mL/min/1.73m^2) 환자 또는 (나) 혈청 creatinine 증가를 보이는 12개월 미만 환자 나) Pyridoxine을 투여해도 반응이 없거나 Pyridoxine 반응성 유전자형※이 아닌 경우	따라, 교과서, 가이드라인, 임상논문, 학회의견, 제외국 평가결과 등을 참조하여 급여기준을 신설함.

		다) 신장결석, 요로결석, 신석회증, 신부전과 같은 임상 증상이 1개 이상 있는 경우 라) 간 이식 병력이 없는 환자 ※Pyridoxine 반응성 유전자형: p.Gly170Arg (G170R), p.Phe152Ile (F152I), p.Ile244Thr (I244T) 2) 1)항에도 불구하고 AGXT 유전자 검사 결과가 확인되기 전인 18세 이하의 환자로서 아래의 조건을 모두 만족하는 경우 투여를 인정함. - 다만, 유전자 검사 결과 AGXT 유전자의 이중대립유전자(biallelic) 변이(pathogenic/likely pathogenic variant)가 확인되고, Pyridoxine 반응성 유전자형이 아닌 경우 지속 투여를 인정하며, 이후의 지속 투여 여부는 나.평가방법을 따름. - 아 래 - 가) 옥살산 측정 수치가 다음 (1), (3) 또는 (2), (3)을 만족하는 경우 - 다 음 - (1) 24시간 요 수집이 가능한 경우 24시간 요 옥살산(UOx, Urine oxalate) 배설량이 정상 상한치(ULN) × 1.5 이상 (2) 24시간 요 수집이 불가하여 단일 검체(Spot urine) 측정을 하는 경우 연령 보정 요 옥살산/크레아티닌 비율(UOx:Cr ratio)이 정상 상한치(ULN) × 1.5 이상 (3) 혈장 옥살산(POx, Plasma oxalate) ≥ 20μmol/L (투석 환자는 투석 전 채혈을 기준으로 함)	

		나) 신장결석, 요로결석, 신석회증, 신부전과 같은 임상 증상이 1개 이상 있는 경우 다) 간 이식 병력이 없는 환자 나. 평가방법 동 약제 투여 후 6개월 시점 효과에 대한 모니터링이 필요하며, 12개월 평가 시 아래에 해당하는 경우 지속 투여를 인정함. 이후 매 12개월 간격으로 평가하여 지속 투여 여부를 결정함. - 아 래 - 1) 요 옥살산: 최초 투여 시점 대비 30% 이상 감소 또는 1.5 × 정상 상한치(ULN) 미만으로 감소 또는 2) 혈장 옥살산: 최초 투여 시점 대비 20% 이상 감소 또는 20μmol/L 미만으로 감소 (단, 요 옥살산 측정이 불가한 경우) 다. 투여중단 간-신장 동시이식(combined liver-kidney transplantation) 또는 간이식을 시행한 경우 2. 최초 투여 시 투여 대상, 지속투여 시 반응평가, 투여중단에 대한 객관적 자료(검사결과지, 진료기록부 등)를 반드시 제출하여야 함. 3. 옥스루모주의 사후관리를 위한 방법·절차 및 위원회 구성 등에 대한 세부사항은 건강보험심사평가원장이 정하고, 동 약제의 고시 적용에 있어 의학적 판단이 필요한 사항은 건강보험심사평가원장이 정하는 위원회 결정에 따름.	

※ 관련근거
1) Current Diagnosis Treatment Pediatrics, 27th Edition (2025)
2) Williams Textbook of Endocrinology (2025)
3) EAU Guidelines on Urolithiasis (2025)
4) Clinical practice recommendations for primary hyperoxaluria: an expert consensus statement from ERKNet and OxalEurope (2023)
5) Sander F. Garrelfs et al. Lumasiran, an RNAi Therapeutic for Primary Hyperoxaluria Type 1 The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE 2021;384;pages 1216-26
6) David J. Sas et al. Phase 3 trial of lumasiran for primary hyperoxaluria type 1: A new RNAi therapeutic in infants and young children Genetics in Medicine 2022;24;pages 654-662
7) Mini Michael et al. Lumasiran for Advanced Primary Hyperoxaluria Type 1: Phase 3 ILLUMINATE-C Trial American Journal of Kidney Diseases 2023;81(2);pages 145-155
8) Yaacov Frishberg et al. Final Results of the ILLUMINATE-A Phase 3 Clinical Trial of Lumasiran for Primary Hyperoxaluria 1 Clinical Journal of the American Society of Nephrology
9) Yaacov Frishberg et al. Efficacy and safety of lumasiran for infants and young children with primary hyperoxaluria type 1: 30-month analysis of the phase 3 ILLUMINATE-B trial Frontiers in Pediatrics
10) Anne-Laure Sellier-Leclerc et al. Efficacy and Safety of Lumasiran for Advanced Primary Hyperoxaluria Type 1: 24-Month Follow-up of the Phase 3 ILLUMINATE-C Trial American Journal of Kidney Diseases 2025;86(2);pages 285-288
11) 대한유전성대사질환학회(유대학 제2026-3호, 2026.1.21.), 대한유전성대사질환학회(유대학 제2026-6호, 2026.3.13.)
12) 대한소아신장학회(대소신 2026-006, 2026.1.23.), 대한소아신장학회(대소신 제2026-011호, 2026.3.13.)
13) 대한신장학회(대신학 2026-020, 2026.2.2.), 대한신장학회(대신학 제2026-054호, 2026.3.11.)
14) NICE(2023.4.19.)
15) PBAC(2025.3.)
16) CAD-AMC(2023.2)
17) HAS (2021.4.21.)

[별지 2]

[일반원칙] 고가의약품 급여관리에 관한 기준

<table>
<tr><th rowspan="2">구 분</th><th colspan="2">세부인정기준 및 방법 개정(안)</th><th rowspan="2">사유</th></tr>
<tr><th>현 행</th><th>개 정(안)</th></tr>
<tr><td>[일반원칙]

고가의약품
급여관리에 관한
기준</td><td>고가의약품 중 아래의 약제를 투여한 경우 관리기간 동안 환자의 투약 및 평가정보를 「요양급여비용 청구방법, 심사청구서·명세서 서식 및 작성요령」에 따라 요양급여비용 명세서에 기재하여 제출하여야 함. 또한, 성과평가 등을 위한 방법·절차 등의 세부사항은 건강보험심사평가원장이 정함.
- 아 래 -
<table><tr><th>약제명</th><th>관리기간</th><th>비고</th></tr><tr><td>킴리아주(Tisagenlecleucel)</td><td>1년</td><td>비호지킨림프종에 투여한 경우</td></tr><tr><td>졸겐스마주(Onasemnogene abeparvovec)</td><td>5년</td><td>-</td></tr><tr><td>스핀라자주(Nusinersen sodium)</td><td>1년</td><td rowspan="2">첫 투여 시 만18세 초과이면서, HFMSE 점수가 5점 미만인 환자에 투여한 경우</td></tr><tr><td>에브리스디건조시럽등(Risdiplam)</td><td>1년</td></tr><tr><td>럭스터나주(Voretigene neparvovec)</td><td>4년</td><td>-</td></tr></table></td><td>고가의약품 중 아래의 약제를 투여한 경우 관리기간 동안 환자의 투약 및 평가정보를 「요양급여비용 청구방법, 심사청구서·명세서 서식 및 작성요령」에 따라 요양급여비용 명세서에 기재하여 제출하여야 함. 또한, 성과평가 등을 위한 방법·절차 등의 세부사항은 건강보험심사평가원장이 정함.
- 아 래 -
<table><tr><th>약제명</th><th>관리기간</th><th>비고</th></tr><tr><td>킴리아주(Tisagenlecleucel)</td><td>1년</td><td>비호지킨림프종에 투여한 경우</td></tr><tr><td>졸겐스마주(Onasemnogene abeparvovec)</td><td>5년</td><td>-</td></tr><tr><td>스핀라자주(Nusinersen sodium)</td><td>1년</td><td rowspan="2">첫 투여 시 만18세 초과이면서, HFMSE 점수가 5점 미만인 환자에 투여한 경우</td></tr><tr><td>에브리스디건조시럽등(Risdiplam)</td><td>1년</td></tr><tr><td>럭스터나주(Voretigene neparvovec)</td><td>4년</td><td>-</td></tr></table></td><td>○ 옥스루모주 신규 등재에 따른 변경</td></tr>
</table>

[일반원칙] 고가의약품 급여관리에 관한 기준

<table>
<tr><th rowspan="2">구 분</th><th colspan="2">세부인정기준 및 방법 개정(안)</th><th rowspan="2">사유</th></tr>
<tr><th>현 행</th><th>개 정(안)</th></tr>
<tr><td></td><td><table><tr><td rowspan="2">과지바주(Dinutuximab beta)</td><td>3년</td><td>고위험군에 투여한 경우</td></tr><tr><td>2년</td><td>재발성·불응성에 투여한 경우</td></tr><tr><td>빌베이캡슐(Odevixibat)</td><td>1년</td><td>-</td></tr><tr><td>리브말리액(Maralixibat)</td><td>5년</td><td>-</td></tr><tr><td>암부트라프리필드시린지주((Vutrisiran)</td><td>1년 6개월</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="3"><신 설></td></tr></table></td><td><table><tr><td rowspan="2">과지바주(Dinutuximab beta)</td><td>3년</td><td>고위험군에 투여한 경우</td></tr><tr><td>2년</td><td>재발성·불응성에 투여한 경우</td></tr><tr><td>빌베이캡슐(Odevixibat)</td><td>1년</td><td>-</td></tr><tr><td>리브말리액(Maralixibat)</td><td>5년</td><td>-</td></tr><tr><td>암부트라프리필드시린지주(Vutrisiran)</td><td>1년 6개월</td><td>-</td></tr><tr><td>옥스루모주(Lumasiran sodium)</td><td>5년</td><td>-</td></tr></table></td><td></td></tr>
</table>

[333] 혈액응고저지제

구 분	세부인정기준 및 방법 현 행	구 분	세부인정기준 및 방법 개 정(안)	사유
[333] Edoxaban Tosilate Hydrate	(생 략)	[333] Edoxaban 경구제	(현행과 같음)	○ Edoxaban besylate hydrate 경구제(품명: 제독사반정 등)의

[333] 혈액응고저지제				
구 분	세부인정기준 및 방법 현 행	구 분	세부인정기준 및 방법 개 정(안)	사유
경구제 (품명: 릭시아나정 15밀리그램 등)		(품명: 릭시아나정 15밀리그램 등)		신규 등재에 따라, 급여기준명을 「Edoxaban 경구제 (품명: 릭시아나정 15밀리그램 등)」로 변경
※ 관련근거 <요양급여 신규등재에 따른 급여기준 변경>				

[399] 따로 분류되지 않는 대사성 의약품			
구 분	세부인정기준 및 방법 현 행	개 정(안)	사유
[399] Burosumab 주사제 (품명: 크리스비타주사액)	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - <신 설>	1. 허가사항 범위 내에서 **X염색체 연관 저인산혈증성(XLH, X-linked hypophosphatemia) 구루병 및 골연화증에** 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - **가. 만 18세 이상** **○ 만 12세 초과 만 18세 미만의 성장판이 닫힌 경우를 포함하며, 골성장판 확인 부위는 무릎을 기준으로 함(무릎 측정이 불가능한 경우 손목 또는 발목도 측정 가능)** **1) 투여대상 및 시작기준** **인산제제 및 활성형 Vitamin D 등 기존 치료제를 6개월 이상 투여하였음에도 적절하게 조절되지 않거나, 신석회증(Grade≥2), 고칼슘혈증 등의 부작용으로 치료를 중단한 경우로서 다음을 모두 만족하는 경우** - 다 음 - **가) PHEX(Phosphate Regulating Endopeptidase X-linked) 유전자 돌연변이가 확인된 경우** **나) 혈청 인 수치(공복 측정) < 2.5 mg/dL** **다) 신장 인 소실 지표(TmP/GFR) 참고치 미만**	○ 식약처 허가사항, 임상진료지침, 임상연구문헌, 전문가 의견 등을 고려하여 만 18세 이상 X 염색체 연관 저인산혈증성(XLH) 골연화증(만 12세 초과 만 18세 미만 성장판 닫힌 경우 포함)에 급여 확대함. ○ 만 1세 이상 만 12세 이하 X염색체 연관 저인산혈증성(XLH) 구루병 급여기준 일부 항목 변경 및 삭제함.

신장 인 소실 지표(TmP/GFR) 참고치, mg/dL(mmol/		
연령	남성	여성
12-16세	3.4－4.6 (1.09－1.47)	3.4－4.6 (1.09－1.4
16-25세	3.33－5.9 (1.07－1.89)	3.18－6.41 (1.02－2
25-45세	3.09－4.18 (0.99－1.34)	2.97－4.45 (0.95－1
45-65세	2.78－4.18 (0.89－1.34)	2.72－4.39 (0.87－1
65-75세	2.47－4.18 (0.79－1.34)	2.47－4.18 (0.79－1

라) 골관절염 평가지수(WOMAC, Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index) total score ≥ 36점 또는 간이 통증 조사지(BPI, Brief Pain Inventory) worst pain ≥ 4점

○ 객관성 확보를 위해 진료담당의사가 아닌 타과 전문의가 평가하여야 함

마) 6분 보행거리 < 정상수치의 50%

※ 6분 보행거리 정상수치

가. 12세 초과 18세 미만

1) 남성: 196.72+(연령×39.81)-(연령^2×1.36)+(신장(m)×132.2

2) 여성: 188.61+(연령×51.50)-(연령^2×1.86)+(신장(m)×86.1

나. 18세 이상

: 868.8-(연령×2.99) -(성별*×74.7)(* 남성: 0, 여성: 1)

바) 방사선학적으로 확인된 골격계 이상소견 (하나 이상 만족)

○ 가성 골절, 골관절염(Kellgren-Lawrence Grade≥2), 척추 퇴행, 척추협착증, 부착병증, 골연화증

2) 평가방법

매 12개월마다 반응 평가를 실시하여, 투여 시작 전 대비 다음 기준을 모두 만족하는 경우 치료 지속하며, 사전심사분과위원회에서 중지가 필요하다고 판단되는 경우는 투여 중지함

- 다 음 -

가) 혈청 인 수치(공복 측정) 증가한 경우

나) 신장 인 소실 지표(TmP/GFR) 증가한 경우

다) 새로운 가성골절(Pseudofracture)이 발생하지 않은 경우(외상성 골절 제외)

라) 신석회증 Grade 2단계 이상 악화되지 않은 경우

3) 동 약제의 요양급여 인정여부에 대하여 사전 신청하여 승인 받은 경우에 한하여 인정함. 단, 사전신청서 제출 후 즉시 투여하는 경우는 추후 승인 시 종전 투여

		분을 소급 인정함. **나. 만 1세 이상 만 12세 이하** **○ 만 12세 초과 만 18세 미만의 성장판이 닫히지 않은 경우를 포함하며, 골성장판 확인 부위는 무릎을 기준으로 함(무릎 측정이 불가능한 경우 손목 또는 발목도 측정 가능)**	
	가. 투여대상 및 시작기준 기존 치료제(활성형 vitamin D 제제 등)를 6개월 이상 지속 투여하였음에도 적절하게 조절되지 않는 만 1세~만 12세 X염색체 연관 저인산혈증성(XLH) 구루병 환자**(단, 만 12세 초과 만 18세 미만인 경우 방사선학적 검사로 골성장 진행이 확인되어 약제 반응이 있을 것으로 판단되는 경우 포함)**로 다음의 조건을 모두 만족하는 경우 - 다 음 - 1) 임상 증상(하나 이상 만족) - 성장지연, 치아이상, 하지골변형, 두개골 조기융합, 두개골 내 압력 상승 등 2) 방사선학적 검사 **- RSS(rickets severity score) 2점 이상** 3) 생화학적 검사(모두 만족) - 저인산혈증(**3.0mg/dL 미만**)	1) 투여대상 및 시작기준 기존 치료제(활성형 vitamin D 제제 등)를 6개월 이상 지속 투여하였음에도 적절하게 조절되지 않는 경우로 다음의 조건을 모두 만족하는 경우 - 다 음 - 가) PHEX 유전자 돌연변이가 확인된 경우 나) **뼈의 이상소견(Bone finding)이 방사선학적으로 확인된 경우** 다) 저인산혈증**(연령별 정상 참고치 미만)**	

	- 신장 인 소실 확인(TmP/GFR 참고치 미만) **- 정상 혈청 크레아티닌** 4) 유전자 검사 - PHEX gene mutation 확인 **나. 제외대상** **다음의 조건 중 어느 하나라도 해당하는 경우 투여시작 대상에서 제외함** - 다 음 - **1) Tanner stage ≥ 4점** **2) 신장(Height) > 연령 및 성별에 대한 50번째 백분위수** **3) 12개월 이내 성장 호르몬 치료를 받은 경우** **4) 부갑상선호르몬(Parathyroid hormone) > 19 pmol/L(180 pg/mL)**	연령 / 인 농도 정상 참고치(mg/dl 1-3세 3.8-6.5 4-11세 3.7-5.6 12-15세 2.9-5.4 16-19세 2.7-4.7 라) 신장 인 소실(TmP/GFR 참고치 미만) 신장 인 소실 지표(TmP/GFR) 참고치 mg/dL(mmol/L) 연령 / 남성 / 여성 1세-2세 3.6-5.4 (1.15-1.73) 3.6-5.4 (1.15-1.7 2세-12세 3.8-5.0 (1.22-1.60) 3.8-5.0 (1.22-1.6 12-16세 3.4-4.6 (1.09-1.47) 3.4-4.6 (1.09-1.4 16-18세 3.33-5.9 (1.07-1.89) 3.18-6.41 (1.02-2.0 마) 임상 증상(하나 이상 만족) ○ 성장지연, 치아이상, 하지골변형, 두개골 조기융합, 두개골 내 압력 상승 등 **바) 신장(Height) ≤ 50번째 백분위수(연령 및 성별)**	

	5) 저칼슘혈증, 고칼슘혈증 **6) Grade 4 이상의 신석회증 (nephrocalcinosis)** 다. 평가방법 매 12개월마다 반응평가(RSS, 방사선학적 검사, 생화학적 검사)를 실시하여야 함 **라. 중지기준** **1) 치료 시작 후 매 12개월 간격의 반응평가 결과가 다음 중 어느 하나라도 해당하는 경우** - 다 음 - **가) RSS(rickets severity score)** **(1) 1차 반응평가(치료시작 후 12개월)에서 RSS 점수가 치료시작 시점보다 개선되지 않은 경우 또는** **(2) 이후 반응평가에서 1차 반응평가 시의 개선된 RSS 점수가 유지되지 않은 경우** 나) 생화학적 검사 결과가 치료시작 기저치 대비 개선되지 않은 경우(하나 이상 해당) (1) 혈청 인 수치 감소 (2) TmP/GFR 감소	2) 평가방법 매 12개월마다 반응 평가를 실시하여, **다음 기준을 모두 만족하는 경우 치료 지속함** - 다 음 - **가) 방사선학적으로 확인된 뼈의 이상소견 (Bone finding)** (1) 1차 평가: 투여 시작 전보다 개선된 경우 (2) 이후 매 12개월마다 평가: 1차 평가 결과 유지된 경우 나) 혈청 인 수치 ○ 투여 시작 전보다 감소되지 않은 경우 다) 신장 인 소실 지표(TmP/GFR) ○ 투여 시작 전보다 감소되지 않은 경우 라) 신석회증 ○ **Grade가 투여 시작 전보다 2단계 이상 악화되지 않은 경우**	

	다) 부갑상선기능항진증 (hyperparathyroidism) **라) 신석회증(nephrocalcinosis)** **마) 방사선학적 평가로 새로 발생한 골절 또는 가골절 확인** 2) 지속투여 중 만 18세가 된 성인 환자 3) 기타 위원회에서 투여 중지가 필요하다고 판단되는 경우 마. 동 약제의 요양급여 인정여부에 대하여 사전 신청하여 승인 받은 경우에 한하여 인정함. 단, 사전신청서 제출 후 즉시 투여하는 경우는 추후 승인 시 종전 투여분을 소급 인정함. 2. 투여 및 약제 관리 가. 원내투여를 원칙으로 함. 다만, 의사는 자가투여 적용의 타당성(즉각적인 용량 변경이 필요 없는 경우 등)을 판단하여 안정된 질병활동도를 보이고 부작용이 없는 환자에서 투여방법에 대해 적절하게 교육 받았을 경우에만 자가 투여를 인정하며, 장기처방 시 1회 처방기간은 최대 4주 분까지로 함.	마) 투여 중 만 18세가 되거나 **성장판이 닫힌 경우 성인의 X-연관 저인산혈증성(XLH) 골연화증의 평가방법, 중지기준을 따르며, 골성장판 확인 부위는 무릎을 기준으로 함(무릎 측정이 불가능한 경우 손목 또는 발목도 측정 가능)** **2. 처방 및 자가투여 관리** **가. 1회 처방기간은 방문 시 투여분을 포함하여 최대 3개월 이내로 한함** 나. 자가투여 적용의 타당성(즉각적인 용량 변경이 필요 없는 경우 등)을 판단하여 안정된 질병활동도를 보이고 부작용이 없는 환자에서 투여방법에 대해 적절하게 교육 받은 경우 자가 투여를 인정함.	

	나. 약제 투여기간 및 관리 등의 확인을 위한 '환자용 투약일지'를 환자가 작성하고 이를 요양기관이 관리하여야 함. 3. 크리스비타주의 사전승인을 위한 방법·절차 및 위원회 구성 등에 대한 세부사항은 건강보험심사평가원장이 정하고, 동 약제의 고시 적용에 있어 의학적 판단이 필요한 사항은 건강보험심사평가원장이 정하는 위원회 결정에 따름.	다. 약제 투여기간 및 관리 등의 확인을 위한 '환자용 투약일지'를 환자가 작성하고 이를 요양기관이 관리하여야 함. **3. 크리스비타주를 성인에 투여하는 경우 사전심사 방법·절차 및 위원회 구성, 사전심사 운영 기간 등에 대한 세부사항은 건강보험심사평가원장이 정함.**	

※ 관련근거
· Dieter Haffner. et al, Clinical practice recommendations for the diagnosis and management of X- linked hypophosphataemia. 2019
· Andrea Trombetti. et al, Interdisciplinary management of FGF23-related phosphate wasting syndromes: a Consensus Statement on the evaluation, diagnosis and care of patients with X-linked hypophosphataemia. 2022
· Craig F Munns. et al, Asia-Pacific Consensus Recommendations on X-Linked Hypophosphatemia: Diagnosis, Multidisciplinary Management, and Transition From Pediatric to Adult Care. 2023
· Insogna KL, et al. A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Phase 3 Trial Evaluating the Efficacy of Burosumab, an Anti-FGF23 Antibody, in Adults With X-Linked Hypophosphatemia: Week 24 Primary Analysis. J Bone Miner Res. 2018 Aug;33(8):1383-93.
· Portale AA, et al. Continued Beneficial Effects of Burosumab in Adults with X-Linked Hypophosphatemia: Results from a 24-Week Treatment Continuation Period After a 24-Week Double-Blind Placebo-Controlled Period. Calcif Tissue Int. 2019 Sep;105(3):271-84.
· Briot K, et al. Burosumab treatment in adults with X-linked hypophosphataemia: 96-week patient-reported outcomes and ambulatory function from a randomised phase 3 trial and open-label extension. RMD Open. 2021 Sep;7(3):e001714.
· Maria Luisa Brandi, et al. Efficacy of Burosumab in Adults with X linked Hypophosphatemia (XLH): A Post Hoc Subgroup Analysis of a Randomized Double Blind Placebo Controlled Phase 3 Study. Calcif Tissue Int. 2022;111(4):409-418.
· Peter Kamenicky, et al. Benefit of burosumab in adults with X-linked hypophosphataemia (XLH) is maintained with long-term treatment. RMD Open. 2023;9(1):e002676.
· Maria Helena Vaisbich, et al. Real-world data of Brazilian adults with X-linked hypophosphatemia(XLH) treated with burosumab and comparison with other worldwide cohorts. Mol Genet Genomic Med. 2024 Feb;12(2):e2387.
· Erik A Imel et al. Burosumab versus continuation of conventional therapy in children with X-linked hypophosphatemia: a randomised, active-controlled, open-label, phase 3 trial, Lancet 2019;393(10189):2416-2427.
- Gibbons WJ, et al. Reference values for a multiple repetition 6-minute walk test in healthy adults older than 20 years. J Cardiopulm Rehabil

2001;21:87-93.
- Ralf Geiger et al, Six-minute walk test in children and adolescents. J Pediatr.2007;150(4):395-9.

[439] 기타의 조직세포의 치료 및 진단

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[439] Aflibercept 주사제 (품명: 아일리아주사, 아일리아프리필드시린지 등)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. (생략) 나. (생략) **다. 망막분지정맥폐쇄성(Branch Retinal Vein Occlusion, BRVO) 황반부종** 1) 투여대상 가) 반대편 눈이 실명(최대교정시력 0.3 이하의 노동력상실 실명)인 경우 나) 반대편 눈의 최대교정시력이 0.4 이상인 경우는 발병 2~3개월이 경과하여도 황반부	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. (현행과 같음) 나. (현행과 같음) **다. 망막정맥폐쇄성(Retinal Vein Occlusion, RVO) 황반부종** 1) 투여대상 가) 반대편 눈이 실명(최대교정시력 0.3 이하의 노동력상실 실명)인 경우 나) 반대편 눈의 최대교정시력이 0.4 이상인 경우는 발병 2~3개월이 경과하여도 황반부	○국내·외 허가사항, 교과서, 가이드라인, 임상논문, 학회(전문가) 의견 등을 참조하여 망막중심정맥폐쇄성(CRVO) 황반부종에 급여 확대함. 아울러, BRVO 및 CRVO 황반부종을 망막정맥폐쇄성(RVO) 황반부종으로 통합하여 급여기준 문구를 개정함.

	종이 지속되면서 최대교정시력이 0.5 이하인 경우 2) 투여횟수: 단안당 총 5회 이내(Ranibizumab 주사제 투여횟수 포함) ※ 황반부종은 빛간섭단층촬영 소견에서 황반두께(Central macular thickness)가 300㎛이상인 경우 라. (생 략)	종이 지속되면서 최대교정시력이 0.5 이하인 경우 2) 투여횟수: 단안당 총 5회 이내(Ranibizumab 주사제 투여횟수 포함) ※ 황반부종은 빛간섭단층촬영 소견에서 황반두께(Central macular thickness)가 300㎛이상인 경우 라. (현행과 같음)	
[439] Ranibizumab 주사제 (품명:루센티스주 등, 루센티스프리필드시린지 등)	각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. (생략) 나. (생략) **다. 망막분지정맥폐쇄성(Branch Retinal Vein Occlusion, BRVO) 황반부종** 1) 투여대상 가) 반대편 눈이 실명(최대교정시력 0.3 이하의 노동력상실 실명)인 경우 나) 반대편 눈의 최대교정시력이 0.4 이상인 경우는 발병 2~3개월이 경과하여도 황반부	각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. (현행과 같음) 나. (현행과 같음) **다. 망막정맥폐쇄성(Retinal Vein Occlusion, RVO) 황반부종** 1) 투여대상 가) 반대편 눈이 실명(최대교정시력 0.3 이하의 노동력상실 실명)인 경우 나) 반대편 눈의 최대교정시력이 0.4 이상인 경우는 발병 2~3개월이 경과하여도 황반부	

	종이 지속되면서 최대교정시력이 0.5 이하인 경우 2) 투여횟수: 단안당 총 5회 이내(Aflibercept 주사제 투여횟수 포함) ※ 황반부종은 빛간섭단층촬영 소견에서 황반두께(Central macular thickness)가 300㎛이상인 경우 라. (생 략)	종이 지속되면서 최대교정시력이 0.5 이하인 경우 2) 투여횟수: 단안당 총 5회 이내(Aflibercept 주사제 투여횟수 포함) ※ 황반부종은 빛간섭단층촬영 소견에서 황반두께(Central macular thickness)가 300㎛이상인 경우 라. (현행과 같음)	

※ 관련근거
· 망막, 5판, 2021
· Ryan's Retina, 7e, 2023
· Vaughan & Asbury's General Ophthalmology, 19e, 2017
· Kanski's Clinical Ophthalmology, 9e, 2020
· Ophthalmology, 6e, 2023
· The Royal College of Ophthalmologists. Clinical Guidelines for Retinal Vein Occlusion (RVO) (2022)
· American Academy of Ophthalmology (AAO). Retinal Vein Occlusions Preferred Practice Pattern (2019)
· Guidelines for the Management of Retinal Vein Occlusion by the European Society of Retina Specialists (EURETINA) (2019)
· Brown DM, et al. Ranibizumab for macular edema following central retinal vein occlusion: six-month primary end point results of a phase III study. Ophthalmology. 2010 Jun;117(6):1124-1133.e1.
· Heier JS, et al. Ranibizumab for macular edema due to retinal vein occlusions: long-term follow-up in the HORIZON trial. Ophthalmology. 2012 Apr;119(4):802-9.
· Campochiaro PA, et al. Long-term outcomes in patients with retinal vein occlusion treated with ranibizumab: the RETAIN study. Ophthalmology. 2014 Jan;121(1):209-219.
· Larsen M, et al. Sustained Benefits from Ranibizumab for Central Retinal Vein Occlusion with Macular Edema: 24-Month Results of the CRYSTAL Study. Ophthalmol Retina. 2018 Feb;2(2):134-142.
· Heier JS, et al. Intravitreal aflibercept injection for macular edema due to central retinal vein occlusion: two-year results from the COPERNICUS study. Ophthalmology. 2014 Jul;121(7):1414-1420.e1.

· Ogura Y, et al. Intravitreal aflibercept for macular edema secondary to central retinal vein occlusion: 18-month results of the phase 3 GALILEO study. Am J Ophthalmol. 2014 Nov;158(5):1032-8.
· Hykin P, et al. Clinical Effectiveness of Intravitreal Therapy With Ranibizumab vs Aflibercept vs Bevacizumab for Macular Edema Secondary to Central Retinal Vein Occlusion: A Randomized Clinical Trial. JAMA Ophthalmol. 2019 Nov 1;137(11):1256-1264.
· Haller JA, et al. Randomized, sham-controlled trial of dexamethasone intravitreal implant in patients with macular edema due to retinal vein occlusion. Ophthalmology. 2010 Jun;117(6):1134-1146.e3.
· Hoerauf H, et al. Clinical Efficacy and Safety of Ranibizumab Versus Dexamethasone for Central Retinal Vein Occlusion (COMRADE C): A European Label Study. Am J Ophthalmol. 2016 Sep;169:258-267.

[619] 기타의 항생물질 제제(복합항생물질제제를 포함)

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[619] Clostridium botulinum A toxin 주사제 (품명: 보톡스주 등)	1. 각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정 기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. (중 략) 다. 방광기능장애환자에게 배뇨일지 또는 객관적으로 검증된 설문지를 첨부토록 하며 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정함.(허가사항에 따라 '보톡스주'만 해당) - 아 래 - 1) 적절한 보존요법(행동치료) 및 항콜린제 투여에 실패한 신경인성 배뇨근 과활동성, 과민성 방광환자 2) 최초 투여 후 증상 호전이 있는 경우 추가투여를 인정하되, 투여간격은 최소 24주는 경과하여야 함 (중 략) 2. 허가사항 범위를 초과하여 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정함. (중 략) 나. 5세 이상-18세 미만 방광기능환자에게 배뇨일지 또는 객관적으로 검증된 설문지를 첨부토록 하며 아래와 같은 기준으로 투여한 경우 - 아 래 - 1) 투여대상: 적절한 보존요법(행동치료) 및 항콜린제 투여에 실패한 신경인성 배뇨근 과활동성인 경우 2) 투여간격: 최초 투여 후 증상 호전이 있는 경우 추가투여를 인정하되, 투여간격은 최소 24주는 경과하여야 함 3) 투여용량: 6U/kg, 최대 200U 초과하지 않음	1. 각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정 기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. (현행과 같음) 다. 방광기능장애환자에게 배뇨일지 또는 객관적으로 검증된 설문지를 첨부토록 하며 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정함.(허가사항에 따라 '보톡스주'만 해당) - 아 래 - 1) 적절한 보존요법(행동치료) 및 항콜린제 투여에 실패한 신경인성 배뇨근 과활동성, 과민성 방광환자 2) 최초 투여 후 증상 호전이 있는 경우 추가투여를 인정하되, 투여간격은 최소 24주는 경과하여야 함 (현행과 같음) 2. 허가사항 범위를 초과하여 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정함. (현행과 같음) 나. 5세 이상-18세 미만 방광기능환자에게 배뇨일지 또는 객관적으로 검증된 설문지를 첨부토록 하며 아래와 같은 기준으로 투여한 경우 - 아 래 - 1) 투여대상: 적절한 보존요법(행동치료) 및 항콜린제 투여에 실패한 신경인성 배뇨근 과활동성인 경우 2) 투여간격: 최초 투여 후 증상 호전이 있는 경우 추가투여를 인정하되, 투여간격은 최소 24주는 경과하여야 함 3) 투여용량: 6U/kg, 최대 200U 초과하지 않음	○ 교과서, 가이드라인, 임상연구문헌, 학회(전문가) 의견 등을 참조하여 성인의 과민성 방광 환자에 급여 확대

	< 추 가 >	다. 방광기능장애환자에게 배뇨일지 또는 객관적으로 검증된 설문지를 첨부토록 하며 아래와 같은 기준으로 투여한 경우 - 아 래 - 1) 투여대상: 적절한 보존요법(행동치료) 및 베타-3 아드레날린 작용제(mirabegron) 투여에 실패한 성인의 과민성 방광 환자 2) 투여간격: 최초 투여 후 증상 호전이 있는 경우 추가투여를 인정하되, 투여간격은 최소 24주는 경과하여야 함 3) 투여용량: 최대 100U 초과하지 않음.	

※ 관련근거

· Campbell-Walsh-Wein Urology, 13e. 2025, chapter 113. Pharmacologic management of lower urinary tract storage and emptying failure
· Goldman-Cecil Medicine, 27e, 2024 chapter115. Urinary Incontinence
· The AUA/SUFU Guideline on the Diagnosis and Treatment of Idiopathic Overactive Bladder (2024)
· Neurogenic Lower Urinary Tract Dysfunction: AUA/SUFU Guideline (2021)
· EAU Guidelines on Non-Neurogenic Male Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS), European Association of Urology (2026)
· EAU Guidelines on Neuro-Urology, European Association of Urology (2026)
· Christopher Chapple, et al. OnabotulinumtoxinA 100 U Significantly Improves All Idiopathic Overactive Bladder Symptoms and Quality of Life in Patients with Overactive Bladder and Urinary Incontinence: A Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial, European Urology, 2013;64, 249-256
· Victor W. Nitti, et al. OnabotulinumtoxinA for the Treatment of Patients with Overactive Bladder and Urinary Incontinence: Results of a Phase 3, Randomized, Placebo Controlled Trial, THE JOURNAL OF UROLOGY. 2013 June vol.189, 2186-2193

· Francisco Cruz, et al. Efficacy and Safety of OnabotulinumtoxinA in Patients with Urinary Incontinence Due to Neurogenic Detrusor Overactivity: A Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled Triall, European Urology, 2011;60, 742-750
· David Ginsberg, et al. Phase 3 Efficacy and Tolerability Study of Onabotulinumtoxin A for Urinary Incontinence From Neurogenic Detrusor Overactivity, THE JOURNAL OF UROLOGY, 2012; 187, 2131-2139
· Kwang Jin Ko, et al. Retrospective Observational Study of Treatment Patterns and Efficacy of onabotulinumtoxinA Therapy in Patients with Refractory Overactive Bladder in Clinical Practice, Toxins. 2023(15), 338
· NICE, Urinary incontinence in neurological disease: assessment and management (2023)
· NICE, Lower urinary tract symptoms in men: management (2015)
· SMC, botulinum toxin type A (Botox®)
· PBS, BOTULINUM TOXIN TYPE A
· AETNA, OnabotulinumtoxinA (Botox Brand of Botulinum Toxin Type A)
· CMS
· NHI

[629] 기타의 화학료법제

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[629] Letermovir 경구제 (품명: 프레비미스정 240,	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 투여대상 : 동종 조혈모세포 이식수술(HSCT)을 받은 거대세포바이러스(CMV)-혈청양성[R+] 성	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 투여대상 : 동종 조혈모세포 이식수술(HSCT)을 받은 거대세포바이러스(CMV)-혈청양성[R+] 성	○ 교과서, 가이드라인, 임상연구문헌, 학회(전문가) 의견 등을 참조하여 소아에서 동종 조혈모세포 이식수술(HSCT)을 받은 거대세포바이러스(CMV) 예방 요법에 급여 확대

480밀리그램), Letermovir 주사제 (품명: 프레비미스주 240, 480밀리그램)	인으로 투여 시작 전 5일 이내 혈청 CMV 검사(PCR)에서 음성으로 확인된 환자 나. 투여방법 : 이식 당일 및 이식 후 28일 이내 투여를 시작하며, 투여기간은 다음과 같음 - 다 음 - 1) 이식 후 100일까지 투여 인정함. 2) 고위험 환자에 해당될 경우 200일까지 투여 인정함. ○ 고위험 환자: HLA(Human leukocyte antigen) 불일치·반일치 이식, 제대혈 이식, ATG(Anti-thymocyte globulin) 투여 이식, 이식편대숙주질환(GVHD)으로 치료중인 환자, 고용량 스테로이드 투여 환자 등 다. 투여중지 기준 1) CMV 질환이 발생한 경우 2) 선제치료(Preemptive therapy)가 필요한 경우: 거대세포바이러스 항원 혈증(CMV antigenemia) (혈액내 CMV 항원 검출) 양성소견이나, 혈액으로 실시한 CMV-PCR검사의 양성소견을 토대로 선제치료가 필요하다고 진료담당의사가 판단한 경우	인 **및 30kg 이상의 소아**로 투여 시작 전 5일 이내 혈청 CMV 검사(PCR)에서 음성으로 확인된 환자 나. 투여방법 : 이식 당일 및 이식 후 28일 이내 투여를 시작하며, 투여기간은 다음과 같음 - 다 음 - 1) 이식 후 100일까지 투여 인정함. 2) 고위험 환자에 해당될 경우 200일까지 투여 인정함. ○ 고위험 환자: HLA(Human leukocyte antigen) 불일치·반일치 이식, 제대혈 이식, ATG(Anti-thymocyte globulin) 투여 이식, 이식편대숙주질환(GVHD)으로 치료중인 환자, 고용량 스테로이드 투여 환자 등 다. 투여중지 기준 1) CMV 질환이 발생한 경우 2) 선제치료(Preemptive therapy)가 필요한 경우: 거대세포바이러스 항원 혈증(CMV antigenemia) (혈액내 CMV 항원 검출) 양성소견이나, 혈액으로 실시한 CMV-PCR검사의 양성소견을 토대로 선제치료가 필요하다고 진료담당의사가 판단한 경우	
※ 관련근거			

· 식품의약품안전처 허가사항
· Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases, 6th edition, 2023, Elsevier. > Chapter 206: Cytomegalovirus
· Feigin and Cherry's Textbook of Pediatric Infectious Diseases, 9th Edition, 2025, Elsevier > Chapter 71: Opportunistic Infections in Hematopoietic Stem Cell Transplantation
· Williams Hematology, 11th Edition. 2026, McGraw Hill > Chapter 29: Hematopoietic Stem Cell Transplantation
· Per Ljungman, et al. Recommendations from the 10th European Conference on Infections in Leukaemia for the management of cytomegalovirus in patients after allogeneic haematopoietic cell transplantation and other T-cell-engaging therapies, ECIL, Lancet Infect Dis, 2025. 25: e451-62
· Fareed Khawaja, et al. American Society for Transplantation and Cellular Therapy Series # 11: Updated Cytomegalovirus Guidelines in Hematopoietic Cell Transplant and Cellular Therapy Recipients, ASTCT, 2025
· Jose Luis Pinana, et al. Update on Cytomegalovirus Infection Management in Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplant Recipients. A Consensus Document of the Spanish Group for Hematopoietic Transplantation and Cell Therapy (GETH-TC), Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases,
· Lindsey Robert Baden, et al. NCCN Clinical practice guidelines in Oncology, Prevention and Treatment of Cancer-Related Infections, Version 1.2026-March 11
· Andreas H. Groll, et al. Cytomegalovirus prophylaxis with letermovir in pediatric (birth to <18 years of age) hematopoietic cell transplant recipients: pharmacokinetics, efficacy, and safety results of a Phase 2b study, Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2025 Oct 69(10), 10.1128/aac.00420-25
· F.M. Marty, et al. Letermovir Prophylaxis for Cytomegalovirus in Hematopoietic-Cell Transplantation, the new england journal of medicine, 2017 Dec 377;25, 2433-2444
· Yoon HS, et al. Cytomegalovirus infection in children who underwent hematopoietic stem cell transplantation at a single center: A retrospective study of the risk factors, Pediatric Transplantation 2009: 13:898.905
· Francesca Vendemini, et al. Letermovir Primary and Secondary Prophylaxis in Pediatric Recipient s of Allogeneic Haematopoietic Stem Cell Transplant, Transplantation and Cellular therapy 31 2025: 699.e1-699.e11
· Monika Richert-Przygonska, et al. Letermovir Prophylaxis for Cytomegalovirus Infection in Children After Hematopoietic Cell Transplantation, ANTICANCER RESEARCH(42) 2022: 3607-3612
· NICE, Letermovir for preventing cytomegalovirus disease after a stem cell transplant (2019)
· SMC, letermovir 240mg film-coated tablets (Prevymis®) (2018)
· CADTH, Canadian Drug Expert Committee Recommendation, Letermovir (2018)
· Ontario Exceptional Access Program Reimbursement Criteria for Frequently Requested Drugs (2025)

· AETNA, Pharmacy Clinical policy bulletins Aetna non-medicare prescription drug plan (2025)
· PBAC(2019)
· Gemeinsamer Bundesausschuss, Resolution, Letermovir (2025)
· NHI, 10.7.12.Letermovir (如Prevymis)